

CONVERSATÓRIO 5 - DECOLONIZAR E INTERCULTURALIZAR AS UNIVERSIDADES: AÇÕES AFIRMATIVAS, JUSTIÇA EPISTÊMICA E OUTROS MODOS DE CONHECER

Educação Permanente, equidade e decolonização da formação médica: um relato de experiência

Thalita Analyane Bezerra de Albuquerque, Afya Faculdade de Ciências Médicas de
Garanhuns, thalita.albuquerque@afya.com.br

Cleide dos Santos Batista, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhus,
cleide.batista@afya.com.br

Larissa Rodrigues Ferreira de Freitas, Afya Faculdade de Ciências Médicas de
Garanhuns, larissa.freitas@afya.com.br

RESUMO

Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido no âmbito do Módulo de Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino VII (PIEPE VII), em articulação com o Módulo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII (IESC VII), no curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Garanhus. A vivência foi orientada pela Educação Permanente em Saúde (EPS), com ênfase nas políticas públicas de promoção da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS), compreendidas como estratégias fundamentais para o enfrentamento das desigualdades sociais, raciais, territoriais, de gênero, sexualidade, trabalho e acesso aos serviços de saúde (Brasil, 2009; Ceccim, 2005).

A experiência partiu da necessidade de aproximar a formação médica dos processos reais de trabalho na Atenção Primária à Saúde (APS), superando uma lógica restrita ao modelo biomédico e fortalecendo práticas comprometidas com integralidade, humanização, participação social e justiça social.

O objetivo da experiência foi desenvolver, junto aos estudantes, ações de planejamento, gestão e EPS voltadas à qualificação dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com foco na discussão crítica das políticas de promoção da equidade e na construção de estratégias educativas alinhadas às demandas dos territórios.

Buscou-se, ainda, favorecer a integração entre estudantes, docentes, preceptores e equipes de saúde, estimulando a escuta, o diálogo e a problematização do cotidiano de trabalho como caminhos para a produção de conhecimento e transformação das práticas em saúde.

As atividades foram realizadas por estudantes do PIEPE VII, sob orientação docente e em integração com o IESC VII e com preceptores vinculados às UBS. O percurso metodológico envolveu planejamento, definição de temas, aproximação com os serviços, elaboração de estratégias educativas e realização de intervenções junto aos trabalhadores da saúde. As ações foram construídas a partir de metodologias participativas, rodas de conversa, exposições dialogadas, dinâmicas, problematização de casos, materiais educativos e discussões sobre situações concretas vivenciadas nos territórios.

Os temas trabalhados envolveram a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) (Brasil, 2017), a saúde das populações do campo, da floresta e das águas (Brasil, 2013a), a atenção à população rural exposta a agrotóxicos, a saúde da população LGBTQIAP+ (Brasil, 2013b), o aperfeiçoamento técnico e ético para a realização de testes rápidos, a saúde mental no trabalho e a importância do trabalho em equipe na APS.

Durante o desenvolvimento das atividades, observou-se boa aceitação por parte da maioria dos profissionais das UBS, sobretudo quando as temáticas foram relacionadas às demandas concretas do processo de trabalho e às situações cotidianas enfrentadas pelas equipes. A participação dos preceptores foi relevante para mediar a aproximação entre estudantes e profissionais, favorecendo a adequação das atividades às realidades locais e ampliando o sentido da integração ensino-serviço-comunidade.

A articulação entre PIEPE VII e IESC VII permitiu que os estudantes compreendessem a EPS não apenas como uma ação pontual de capacitação, mas como uma estratégia pedagógica e política que parte dos problemas reais do território, reconhece os saberes dos trabalhadores e estimula a construção coletiva de soluções (Brasil, 2009; Ceccim, 2005).

Os resultados indicaram que as atividades favoreceram o debate sobre equidade em saúde, especialmente ao trazer para o centro da formação médica sujeitos e grupos historicamente invisibilizados ou negligenciados pelas práticas tradicionais de cuidado. As discussões sobre a PNSIPN contribuíram para refletir sobre o racismo estrutural e institucional, seus impactos na produção do adoecimento e as responsabilidades da APS na garantia do acesso, acolhimento e cuidado qualificado da população negra (Brasil, 2017). As abordagens sobre populações do campo, da floresta e das águas e população rural exposta a agrotóxicos possibilitaram problematizar as relações entre saúde, trabalho, ambiente, território e modos de vida (Brasil, 2013a), ampliando a compreensão dos estudantes acerca dos determinantes sociais e socioambientais do processo saúde-doença.

As ações sobre saúde da população LGBTQIAP+ mobilizaram reflexões sobre acolhimento, respeito ao nome social, enfrentamento da LGBTfobia, barreiras de acesso e necessidade de práticas de cuidado livres de discriminação (Brasil, 2013b). Já as atividades relacionadas aos testes rápidos possibilitaram o aperfeiçoamento técnico dos profissionais e estudantes, articulando biossegurança, aconselhamento, sigilo, ética e acolhimento. As discussões sobre saúde mental e trabalho em equipe também se mostraram relevantes, por favorecerem a reflexão sobre sofrimento psíquico, comunicação entre profissionais, corresponsabilização, apoio mútuo e construção de redes de cuidado no âmbito da APS.

Apesar da boa receptividade geral, algumas equipes apresentaram resistência ou baixa participação, o que também se constituiu como elemento formativo importante. Tais situações evidenciaram desafios persistentes para a implementação da EPS nos serviços de saúde, como sobrecarga de trabalho, pouca disponibilidade de tempo, fragilidades na cultura institucional de educação permanente e possíveis resistências relacionadas ao debate de temas sensíveis, especialmente aqueles vinculados às desigualdades, preconceitos e direitos de populações historicamente vulnerabilizadas. Esses limites reforçaram a necessidade de processos educativos contínuos, dialógicos e territorializados, capazes de reconhecer conflitos, tensões e contradições presentes no cotidiano do SUS.

A experiência demonstrou que os objetivos do PIEPE VII e do IESC VII foram alcançados, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de competências relacionadas ao planejamento, à gestão, à Educação Permanente em Saúde e à abordagem das políticas de promoção da equidade. Para os estudantes, a vivência permitiu compreender que a formação médica deve ir além do domínio técnico-clínico, incorporando dimensões éticas, políticas, sociais, culturais e territoriais do cuidado. Ao entrarem em contato com profissionais, preceptores e serviços, os estudantes foram convocados a deslocar o olhar biomédico e individualizante para uma compreensão ampliada da saúde, fundamentada na integralidade, na equidade e na defesa do SUS.

Conclui-se que a orientação de atividades de Educação Permanente em Saúde no PIEPE VII, em integração com o IESC VII e com os preceptores da UBS, constituiu uma experiência potente para a formação médica humanitária, crítica e socialmente comprometida. A vivência possibilitou o fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade, a valorização dos trabalhadores da APS e o reconhecimento da equidade como princípio indispensável para a produção do cuidado. Ao trabalhar políticas voltadas à população negra, às populações do campo, da floresta e das águas, à população rural exposta a agrotóxicos, à população LGBTQIAP+, aos testes rápidos, à saúde mental e ao trabalho em equipe, a experiência contribuiu para formar futuros médicos mais sensíveis às desigualdades e mais preparados para atuar em defesa da vida, da dignidade e dos direitos humanos no SUS.

PALAVRAS-CHAVE

Educação Permanente em Saúde; Equidade em saúde; Formação médica; Atenção Primária à Saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política para o SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013a.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2013b.

CECCIM, Ricardo Burg. **Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário**. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 9, n. 16, p. 161-168, 2005.